

Desidratação · classificação e TRO

Classifique pela clínica, prefira terapia de reidratação oral (TRO) quando possível e reserve EV para choque ou falha da via oral.

Escada prática: leve !' moderada !' grave / choque.



Classificação clínica (visão de prova)

| **Leve** | **Moderada** | **Grave**

Estado geral | Alerta, inquieto | Irritado / sonolento | Letárgico / choque

Olhos / fontanela | Normais | Fundos | Muito fundos

Lágrimas / mucosa | Presentes / úmida | !" lágrimas / seca | Ausentes / muito seca

Turgor | Normal | Diminuído | Sinal da prega

Diurese | Normal / !" leve | Reduzida | Oligúria / anúria

Conduta-resumo

- Leve/moderada sem vômitos incoercíveis: TRO com SRO (OMS) em pequenos volumes frequentes
- Manter aleitamento; evitar sucos e refrigerantes como 'reidratação'
- Grave / choque: acesso EV, expansão conforme protocolo (ex.: SF 0,9% em bolus) e reavaliação
- Zinco em diarreia aguda (quando indicado pela diretriz) e orientar sinais de alarme

Plano A / B / C (MS)

Lembre - Plano A / B / C (MS)

Plano A: prevenção da desidratação em casa. Plano B: TRO supervisionada na unidade. Plano C: reidratação venosa na desidratação grave.

Armadilha

Atenção - Armadilha

Criança 'só um pouco quieta' com pulso fino e extremidades frias pode já estar em choque — trate como grave.